

EMESIS POR QUIMIOTERAPIA

María García Rodríguez

INTRODUCCIÓN

Aproximadamente un 50% de las pacientes en tratamiento quimioterápico presentarán como efecto secundario náuseas o vómitos. Estos van a depender de dos factores; en primer lugar, del potencial emetógeno del propio quimioterápico (alto, moderado, bajo y mínimo) y en segundo lugar, de factores que van a venir determinados por el propio paciente.

Tanto la asociación **MASCC** (Multinational Association for Supportive Care in Cancer) como el National Cancer Comprehensive Network (**NCCN**) y la Sociedad Americana de Oncología Médica (**ASCO**) han establecido escalas de emetogenicidad de los citotóxicos, estableciendo también unas líneas maestras para el tratamiento de la emesis por quimioterapia.

Se han definido tres tipos de emesis post-quimioterapia según su momento de aparición, suponiendo que tienen mecanismos patogénicos diferentes: **aguda** (ocurre en las primeras 24 h), **diferida** (ocurre después) y **anticipatoria** (antes de la administración del fármaco; se debe a un reflejo condicionado).

National
Comprehensive
Cancer
Network®

NCCN Guidelines Version 2.2014

Antiemesis

[NCCN Guidelines Index](#)
[Antiemesis Table of Contents](#)
[Discussion](#)

EMETOGENIC POTENTIAL OF INTRAVENOUS ANTINEOPLASTIC AGENTS^W

LEVEL	AGENT
High emetic risk (≥90% frequency of emesis) ^{1,2,3}	• AC combination defined as either doxorubicin or epirubicin with cyclophosphamide⁴ • Carmustine >250 mg/m² • Cisplatin • Cyclophosphamide >1,500 mg/m² • Dacarbazine • Doxorubicin ≥60 mg/m² • Epirubicin >90 mg/m² • Ifosfamide ≥2 g/m² per dose • Mechlorethamine • Streptozocin
Moderate emetic risk (30%-90% frequency of emesis) ^{1,2,3}	• Aldesleukin >12-15 million IU/m² • Amifostine >300 mg/m² • Arsenic trioxide • Azacitidine • Bendamustine • Busulfan • Carboplatin⁵ • Carmustine ≤250 mg/m² • Clofarabine • Cyclophosphamide ≤1,500 mg/m² • Cytarabine >200 mg/m² • Dactinomycin⁶ • Daunorubicin⁷ • Doxorubicin <60 mg/m² • Epirubicin ≤90 mg/m² • Idarubicin • Ifosfamide⁸ <2 g/m² per dose • Interferon alfa ≥10 million IU/m² • Irinotecan⁹ • Melphalan • Methotrexate¹⁰ ≥250 mg/m² • Oxaliplatin • Temozolomide

Adapted with permission from:

Henkeith PJ, et al. Proposal for classifying the acute emetogenicity of cancer chemotherapy. J Clin Oncol 1997;15:103-109.

Guarnero SM, Warr D, Gallia RL, et al. Evaluation of new adjuvant agents and definition of antineoplastic agent emetogenicity-state of the art. Support Care Cancer. 2010;19:S43-47.

Adapted with permission from:
 Heskeeth PJ, et al. Proposal for classifying the acute emetogenicity of cancer chemotherapy. J Clin Oncol 1997;15:103-109.
 Grunberg SM, Warr D, Gralla RJ, et al. Evaluation of new antiemetic agents and definition of antineoplastic agent emetogenicity-state of the art. Support Care Cancer. 2010;19:S43-47.

Imagen 1. Clasificación citostáticos intravenosos NCCN 2014

En la fase aguda las aferencias que llegan al centro del vómito son sobre todo del sistema nervioso periférico y tienen como mediador fundamental la **serotonina**.

En la fase diferida las aferencias que llegan al centro del vómito son del sistema nervioso central y es la **sustancia P** el principal mediador. Teniendo en cuenta dicha fisiopatología mejoraremos el abordaje terapéutico en urgencias.

DIAGNÓSTICO

Para un correcto abordaje diagnóstico realizaremos una **anamnesis completa** incidiendo en: el momento de aparición, la relación con la ingesta, la presencia/ausencia de síntomas acompañantes (dolor abdominal, orofaríngeo o cervical, alteración en las deposiciones, fiebre), el número de episodios al día y los factores de riesgo (asociados al tipo de quimioterápico y asociados al propio paciente)

La **exploración física** debe ser exhaustiva y podemos ayudarnos de pruebas complementarias:

- **Hemograma.**

- **Bioquímica** con glucosa, urea, creatinina, sodio, potasio, cloro, calcio, GOT, GPT, GGT, amilasa, bilirubina total y fraccionada, PCR.
- **Coagulación básica.**
- **Gasometría venosa.**
- **Rx de tórax y abdomen:** ante sospecha de vómitos por causa mecánica (fecaloma, perforación, obstrucción o pseudo-obstrucción por bridas postquirúrgicas, fibrosis post-RT, carcinomatosis peritoneal, etc)

TRATAMIENTO EN URGENCIAS

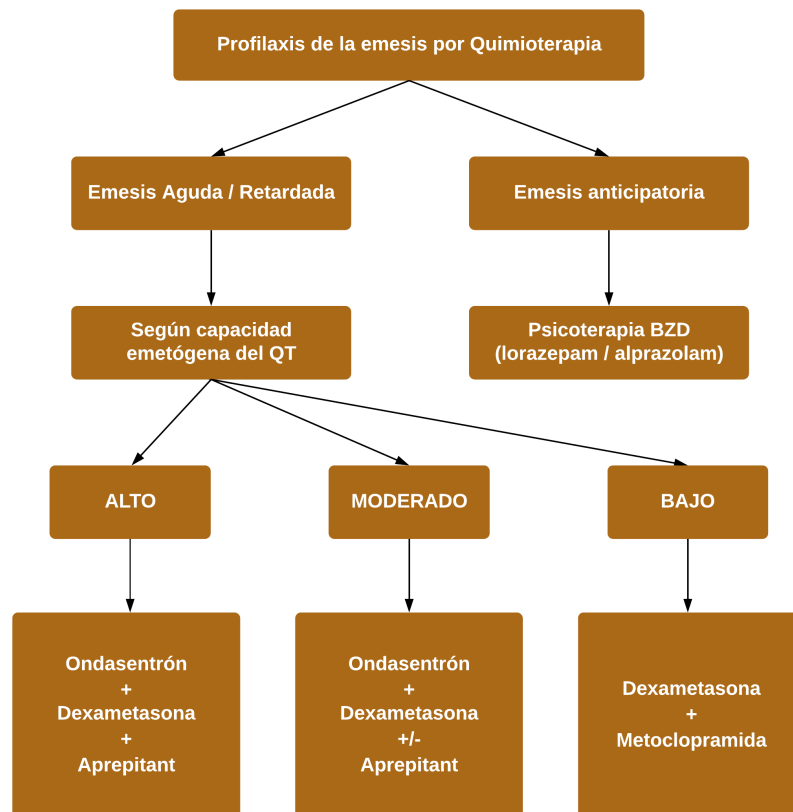
El tratamiento de la emesis por quimioterapia resulta menos eficaz que la prevención de esta. La profilaxis, es pues, el objetivo principal de la terapia antiemética.

Emesis Anticipatoria

Las benzodiazepinas (BZD) no han mostrado actividad antiemética intrínseca; sin embargo, han demostrado ser útiles como coadyuvantes asociadas a otros antieméticos. Preferiblemente las de vida media corta como alprazolam (0.5-2mg vo) o lorazepam (0.5-2mg vo).

Emesis Aguda O Retardada

- **Antidopaminérgicos:** metoclopramida (10-20 mg vo/iv), clorpromazina (25-50mg vo/iv/sc) y Haloperidol (2.5- 5 mg vo/sc)
- **Antagonistas de la serotonina (antagonistas 5-HT3):** Se consideran antieméticos de elevado índice terapéutico y resultan muy efectivos en el tratamiento y prevención de la emesis por quimioterapia. Ondasentrón (8mg iv/vo), granisetron (1 mg/vo o 3mg/iv), tropisetron (5mg vo/iv) y palonosetrón (0.25mg/iv)
- **Corticoides:** Dexametasona (8-20mg vo/iv) y Metilprednisolona (40-125mg vo/iv)
- **Antagonistas de la neurocinina 1 (receptor NK-1):** Aprepitant es un nuevo antiemético que bloquea de forma selectiva el receptor de la neurocinina en los sistemas nerviosos periférico y central, por lo que reduce la estimulación de la respuesta emética. Está indicado en la prevención de las náuseas y vómitos agudos/diferidos asociados a quimioterapia antineoplásica moderada y altamente emetógena en adultos. Asociado a una terapia estándar de dexametasona y un antagonista 5-HT3, es capaz de incrementar la respuesta antiemética.



BIBLIOGRAFÍA

- Navari RM, Aapro M. Antiemetic prophylaxis for chemotherapy-induced nausea and vomiting. N Engl J Med. 2016;374:1356–1367. doi: 10.1056/NEJMr1515442.
- Roila F, Molassiotis A, Herrstedt J, participants of the MASCC/ESMO Consensus Conference Copenhagen 2015 et al (2016) 2016 MASCC and ESMO guideline update for the prevention of chemotherapy- and radiotherapy-induced nausea and vomiting and of nausea and vomiting in advanced cancer patients. Ann Oncol 27(suppl 5):v119-v133.
- Hesketh PJ, Kris MG, Basch E, et al. Antiemetics: American Society of Clinical Oncology clinical practice guideline update. J Clin Oncol. 2017;35:3240–3261.